

PANCREATITE BILIAR — VOLUME, GRAVIDADE, VESÍCULA

DIAGNÓSTICO E ETIOLOGIA BILIAR

Aspecto	Detalhe
Diagnóstico (2 de 3)	Dor abdominal típica + amilase/lipase > 3x o limite + imagem compatível
Causa biliar	Cálculo biliar é a causa mais comum no Brasil (junto com álcool)
Pistas de origem biliar	TGP/ALT elevada (> 3x), bilirrubina/FA elevadas, USG com colelitíase
Exame inicial	USG de abdome (cálculos, via biliar) em todo paciente com pancreatite
Lipase	Mais específica e sensível que a amilase; o valor NÃO indica gravidade
Colangite associada	Febre + icterícia + dor (triade de Charcot) = urgência de drenagem biliar

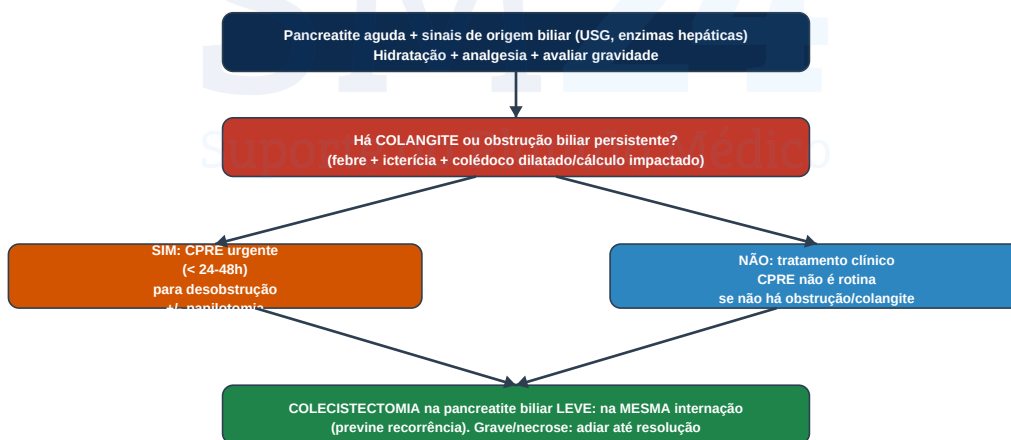
O QUE MAIS IMPORTA NAS PRIMEIRAS HORAS

HIDRATAÇÃO E AVALIAÇÃO DE GRAVIDADE

- Hidratação com cristalóide (Ringer lactato preferido) guiada por metas — evitar tanto a hipovolemia quanto a hiper-hidratação
- Analgesia adequada (opióide se necessário) e controle de náuseas
- Dieta: reiniciar precocemente VO conforme tolerância na pancreatite leve (não manter jejum prolongado)
- Avaliar gravidade: SIRS persistente, BISAP, ureia/creatinina em ascensão, hematócrito alto
- Antibiótico NÃO é profilático de rotina — apenas se infecção documentada (colangite, necrose infectada)
- A maioria das pancreatites é leve e autolimitada; identificar precocemente a forma grave

MANEJO INTEGRADO DA PANCREATITE BILIAR

PANCREATITE BILIAR — CPRE? COLECTOMIA QUANDO?



GRAVIDADE (CLASSIFICAÇÃO DE ATLANTA REVISADA)

Forma	Definição	Conduta
Leve	Sem falência orgânica nem complicações locais	Suporte, dieta precoce, colecistectomia na mesma internação
Moderadamente grave	Falência orgânica transitória (< 48h) ou complicação local	Internação, suporte, vigiar complicações
Grave	Falência orgânica PERSISTENTE (> 48h)	UTI, suporte intensivo; manejar necrose conforme evolução
Necrose infectada	Suspeita por piora/gás na imagem após 1a semana	Antibiótico + drenagem/necrosectomia (step-up), de preferência tardia
BISAP	Ureia, alteração mental, SIRS, idade, derrame pleural	Escore prognóstico simples à beira-leito

CPRE E COLECTOMIA

CPRE — Indicações

- Colangite associada (urgente, < 24-48h)
- Obstrução biliar persistente / cálculo impactado no colédoco
- CPRE NÃO é rotina na pancreatite biliar sem obstrução/colangite
- Colangiressonância ou USG endoscópica para avaliar o colédoco em risco intermediário
- CPRE precoce não melhora desfecho se não há obstrução
- Papilotomia trata e previne novos episódios obstrutivos

Colecistectomia

- Pancreatite biliar LEVE: colecistectomia na MESMA internação (reduz recorrência)
- Adiar não é seguro — risco alto de recidiva enquanto a vesícula está presente
- Pancreatite grave/com necrose ou coleções: adiar até a resolução do quadro
- Se não operar de imediato (alto risco cirúrgico): considerar papilotomia endoscópica
- Sempre confirmar via biliar livre antes/durante a cirurgia
- Orientar quanto à recorrência se a colecistectomia for postergada

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Confirmar o diagnóstico (2 de 3) e investigar origem biliar com USG + enzimas hepáticas
- ☐ Hidratação guiada por metas (Ringer lactato), analgesia e dieta precoce na forma leve
- ☐ Avaliar gravidade (SIRS, BISAP, ureia/creatinina) e definir o nível de cuidado
- ☐ Antibiótico apenas se infecção documentada (colangite, necrose infectada) — não profilático
- ☐ CPRE urgente se colangite/obstrução biliar persistente
- ☐ Colecistectomia na mesma internação na pancreatite biliar leve; adiar na grave/necrose

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com pancreatite aguda biliar LEVE, sem colangite. Qual a conduta quanto à colecistectomia?

- A) Adiar por 6 semanas após a alta
- B) Realizar a colecistectomia na MESMA internação para prevenir recorrência
- C) Nunca operar, apenas dieta
- D) Operar somente se houver novo episódio
- E) Indicar CPRE em vez de colecistectomia para todos

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Quando a CPRE de urgência está indicada na pancreatite biliar?

- A) Em todos os pacientes com pancreatite biliar
- B) Apenas quando há colangite associada ou obstrução biliar persistente
- C) Somente na pancreatite grave sem obstrução
- D) Quando a lipase está muito elevada
- E) Nunca está indicada

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Sobre o uso de antibiótico na pancreatite aguda, qual afirmação é correta?

- A) Deve ser profilático em todos os casos
- B) É indicado apenas quando há infecção documentada (colangite, necrose infectada), não como profilaxia de rotina
- C) Deve ser usado se a amilase estiver muito elevada
- D) Reduz a mortalidade quando dado a todos profilaticamente
- E) É contraindicado em qualquer situação

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual fluido é preferido para a ressuscitação volêmica inicial na pancreatite aguda?

- A) Soro glicosado 5%
- B) Ringer lactato (cristaloide), guiado por metas
- C) Albumina humana
- D) Solução salina hipertônica
- E) Manitol

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Paciente com pancreatite biliar evolui com febre alta, icterícia e dor (tríade de Charcot). O que isso indica?

- A) Necrose pancreática estéril
- B) Colangite aguda associada — indicação de drenagem biliar (CPRE) urgente
- C) Pseudocisto pancreático
- D) Resolução do quadro
- E) Pancreatite alcoólica

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Na pancreatite biliar LEVE, a colecistectomia deve ser realizada na MESMA internação. Adiar aumenta o risco de recorrência (novo episódio de pancreatite, colangite ou cólica) enquanto a vesícula litiásica permanece.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A CPRE de urgência está indicada quando há colangite associada ou obstrução biliar persistente (cálculo impactado). Na pancreatite biliar sem obstrução/colangite, a CPRE não é rotina e não melhora o desfecho.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O antibiótico NÃO deve ser profilático na pancreatite aguda. É indicado apenas quando há infecção documentada — colangite associada ou necrose pancreática infectada. O uso profilático de rotina não reduz a mortalidade.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O Ringer lactato (cristaloide) é o fluido preferido para a ressuscitação inicial da pancreatite aguda, com reposição guiada por metas para evitar tanto a hipovolemia quanto a hiper-hidratação.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A tríade de Charcot (febre + icterícia + dor) indica colangite aguda associada, que é uma urgência: requer antibiótico e drenagem biliar (CPRE) precoce para desobstruir a via biliar e controlar a sepse.

SM24
Suporte ao Plantão Médico